

流感感冒发烧、咳嗽家庭应对指南，二羊干货总结，请收藏好！

原创 二羊 养阳医斋 2025年11月10日 22:56 广东

从上周开始，感冒发烧的孩子又多起来，这又让我想起去年的支原体感染。每一次突如其来的病潮袭来，无论从甲流到新冠，再到支原体感染等，我都在临床实践中摸索着应对，总结出一些经验。

这类流行性疾病的共性十分鲜明：病情发展快、顽固易反复、传播迅速且波及人群广。面对潮水般袭来的病症，与其纠结于“寒湿”“湿热”“温病”“瘟疫”等众说纷纭的学术定义，不如聚焦具体患者的辨证施治——在一次次接诊、处理中，我总结出一些可以反复使用的经验和心得，现在总结一些精要分享给大家。

一、先辨病：流感与普通感冒的核心区别

很多家长容易把流感和普通感冒混淆，导致用药不当、延误病情。二者在病因、症状、病情进展上差异显著，中医辨证思路也不同，具体对比如下：

对比维度	普通感冒	流感（甲流、乙流等）
病因	多由鼻病毒、冠状病毒等普通病毒引起，传染性弱	由流感病毒（甲、乙、丙型）引起，传染性极强，易爆发流行
发病速度	起病缓慢，症状逐渐加重	起病急骤，几小时内出现高热等症状
发热表现	多为低热或中度发热（37.3-38.5℃），持续1-2天	高热为主（38.5℃以上），常持续3-5天，甚至更久
全身症状	轻微，以鼻塞、流涕、咽痛、轻微咳嗽为主，无明显肌肉酸痛、乏力	严重，伴随全身肌肉酸痛、头痛、乏力、食欲不振、畏寒寒战
病程时长	短，5-7天可自愈	长，7-14天，部分患者咳嗽、乏力可持续2-3周
中医核心病机	多为“风寒或风热袭表”，病情轻浅，以表证为主	多为“热毒炽盛、侵袭肺胃”，表里同病，易化热伤津

对比维度	普通感冒	流感（甲流、乙流等）
辨证要点	侧重区分风寒、风热，以解表为主	侧重清热解毒、生津护津，需兼顾表里同治

⚠️ 关键提醒：若无明显诱因出现“**高热+全身肌肉酸痛+乏力**”三联征，大概率是流感而非普通感冒，需及时按流感辨证用药，避免用普通感冒的轻症方药延误病情。

普通感冒：对症参考

普通感冒（风寒太阳伤寒型）：身体疼痛，鼻塞、恶寒无汗、舌淡苔白 → 推荐感冒清热颗粒、咳嗽用：通宣理肺丸。

普通感冒，太阳中风型：鼻塞流清涕、喷嚏，怕风，桂枝汤（颗粒）。

普通感冒：（风热型）：咽痛流黄涕、轻微发热、舌红苔薄黄 → 推荐银翘解毒片、风热感冒颗粒。

也可以参考：[倪海厦治疗感冒发烧精要总结16大经方](#)

二、流行性发热病症发展规律（四阶段进程）

流感、新冠、支原体感染等流行性疾病，发病到康复可清晰划分为四个阶段，用“烧一锅水”模型能直观理解：

- 发热伴咽喉症状期**
以风热/热毒证多见，好比灶台点火后，水开始升温冒热气，核心是“热邪初起，侵袭上焦”。
- 高烧难退期**
表现为高热无汗、怕热，或汗出后仍不退热，如同锅里的水越烧越旺，甚至锅底发红，核心是“里热炽盛，津液耗伤”。
- 退烧后反复咳嗽期**
高热退去但咳嗽迁延，好比锅里的饭烧焦后需清理残渣，核心是“痰邪滞留，肺失宣降”。
- 康复调理期**
咳嗽减轻、胃口恢复，如同锅内残渣清理完毕，需加水养胃，核心是“脾胃虚弱，需温和调理”。

三、分阶段中医辨证施治方案

（一）第一阶段：发热伴咽喉症状（风热/热毒初起）

⚠ 误区警示：切勿盲目套用麻黄汤、桂枝汤等辛温解表方，否则会加重内热，导致发热更剧烈。需要看具体情况来处理，几轮流感下来，我发现小孩化热特别快！就是你还来不及发汗解表，他就已经很热了！

核心治法：辛凉解表、清热利咽（普通感冒）；清热解毒、透表散邪（流感），及时“揭开锅盖散热气”。

推荐方剂 / 药物

- 经方首选：麻黄杏仁甘草石膏汤、大青龙汤（针对热重无寒的核心病机）。
- 对症逻辑：用偏凉的发汗药（风热类感冒药），快速宣散上焦热邪，多数情况下可截断病情进展；若延误则易转入高烧阶段。
- 流感专属：可加用金银花、连翘，板蓝根等清热解毒药，增强抗病毒之力。

（二）第二阶段：高烧难退（里热炽盛）

⚠ 误区警示：不可再用麻黄、桂枝等发汗药，普通退烧发汗药也无效，反而会耗伤津液。

核心治法：滋阴清热 + 通腑泻热，双管齐下“上边加冷水、下边灭柴火”。

推荐方剂 / 药物

- 中成药：小儿梔翘颗粒、羚羊角颗粒、连花清瘟胶囊（成药力度不足时需用中药汤剂）。
- 经方首选：大柴胡汤、增液承气汤、升降散。
- 对症逻辑：高热易导致“人被烧干”，滋阴可补充耗伤的津液，通大便能引热下行，从根源上清除里热。

（三）第三阶段：退烧后反复咳嗽（痰邪滞留）

⚠ 误区警示：禁用中枢性强制止咳药，否则痰邪无法排出，可能引发肺炎加重、肺内痰栓，或遗留顽痰导致哮喘。

核心治法：辨证化痰（分寒热燥湿）+ 消食导滞（儿童关键），如同“清理锅内烧焦残渣”。

辨证用药指南

- 干咳痰少、痰干结难出：润肺化痰，可选复方鲜竹沥口服液。
- 痰偏热、黄稠难咳：清热化痰，推荐清金化痰汤、蛇胆川贝类药物。
- 痰偏寒、清白稀薄：燥湿化痰，可用二陈丸、橘红痰咳液。
- 儿童专属：需搭配消食导滞药（如小儿化积止咳口服液），避免积食导致病情反复；饮食需清淡，忌高蛋白食物。

（四）第四阶段：康复调理期（脾胃虚弱）

核心原则：不可操之过急进补，需以调理脾胃为核心，兼顾体质差异。

分体质调理方案

偏热体质：用独角金 + 太子参 + 麦冬（或沙参），煮水或炖汤，滋阴健脾不滋腻。

偏寒体质：用小建中汤（煮水或药膏方，如二羊朋友圈的小建中棒棒糖），温养脾胃阳气。

关键逻辑：脾胃为“后天之本”，康复期脾胃功能虚弱，温和调理才能促进津液生成，巩固疗效。

四、紧急处理关键：发热与咳嗽的快速辨证要点

（一）发热辨证（分表热、里热）

类型	核心症状	正确做法	推荐药物
表热	发热伴恶寒、小便清	需捂汗，辛温 / 辛凉解表	风寒感冒颗粒、感冒清热颗粒（咽喉红肿用风热类感冒药）
里热	发热反恶热、讨厌盖被、口渴明显、小便黄	忌捂汗、忌喝生姜水，清热泻火	小儿枢翹颗粒、肺热清瘟颗粒

（二）咳嗽辨证（分寒热痰质）

- 偏寒咳嗽：清鼻涕、痰清白、舌头淡苔白润，需要温肺散寒，推荐小青龙颗粒、通宣理肺丸。
- 偏热咳嗽：黄稠鼻涕、痰黄稠，需要清肺化痰，推荐小儿肺热咳喘颗粒、蛇胆川贝类药物。

五、临床核心总结与提醒

先辨病再辨证

先区分普通感冒与流感，避免“小病用重药”或“重病用轻药”。普通感冒侧重解表，流感侧重清热解毒，二者不可混淆。

辨证是关键

中医无“万能特效方”，本次支原体等感染的核心特点是“易化热”——初期未及时解表，很快会转为里热，这与新冠的病机相似，可参考新冠的清热、滋阴思路应对。

西医局限提示

目前临床常用的阿奇霉素已出现耐药性，部分患者用药 4-5 天后病情仍无进展，甚至咳嗽加重，此时转向中医辨证施治往往能见效。

儿童辨证技巧

小朋友无法准确表述不适，重点观察两点：一是舌头颜色（红 = 热、淡 = 寒），二是汗出情况（有汗 / 无汗），再结合痰质、鼻涕颜色判断，用药前务必对照症状看说明书，避免错用加重病情。

核心逻辑

这类疾病的本质是“热邪 + 痰邪”作祟，治疗需遵循“先清后调”——先快速清热、排痰，再温和调理脾胃，每一步都需对症，不可盲目用药。

六、常用感冒中成药辨证选用思维导图总结

家庭常用中成药，选用思维导图：支原体、流感肺炎发烧、咳嗽如何选用中成药？请收藏好咯！全面梳理教你会用

最后：

中医看上去复杂，但学会一些基本的辨证并不难！

看看吃喝拉撒睡，看看舌头大小便，再问问病人自己的一些感受。就能判断出个大概方向来。

方向搞明白了，很多的中成药就会用了。

再学一点方药，经络穴位知识，针对性的调理方法就有了。

中医看上去慢，很多时候并不慢，好得彻底。

西医方法看上去快，很多时候需要药物依赖。

附录：

[📖 流感如何快速阻断？再次分享我总结的思路和方药](#)

[📖 孩子突然感冒发烧了！了解这些可以不慌](#)

[📖 最近天气恶略感冒的人很多！常用的中成药](#)

[📖 感冒发烧中成药怎么选用？经方思路以及常用的成药推荐，二羊建议收藏！](#)

[📖 寒潮来袭请大家务必准备好！治感冒发烧的10大经方，而不是莲花清瘟](#)

[📖 倪海厦治疗感冒发烧精要总结16大经方](#)

[📖 感冒了古中医怎么辩证？二羊笔记分享，医圣张仲景《伤寒论》辩证思维总结](#)

[📖 医圣治疗感冒的精华全在这，5大经方感冒3天可搞定](#)

二羊治新冠等案例：

[📖 新冠五个疑难退烧案，这类高烧发不出汗！怎么办](#)

[📖 新冠发烧身体痛！30多个例1剂病退！关键第一步你得这样做](#)

如果有缘看到请点赞，正在看并分享给你的家人朋友，让大家少走弯路！

我是中医二羊

中医是一种爱好，一种态度，也是一种生活。

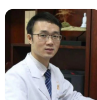




养阳医斋

陪伴帮助自学中医的朋友，以中医四大经典：黄帝内经、伤寒论、金匱要略和神农本草...
518篇原创内容

公众号



二羊

“ 码字不易，感谢支持 ”

喜欢作者

中医实践录 · 目录

上一篇 · 50 岁大姐控饮食身体消瘦仍尿酸血脂高！中医告诉你代谢病真相：问题不在吃

作者提示: 个人观点，仅供参考